

Hypothyroïdie → hypochlorhydrie → carence en fer

Un axe digestif–thyroïdien sous-estimé

Quand la thyroïde ralentit, tout le métabolisme ralentit, y compris :

la motricité digestive

la sécrétion d'acide chlorhydrique (HCl)

l'activité enzymatique

la sécrétion des facteurs d'absorption

On parle alors très souvent de :

Hypochlorhydrie fonctionnelle

même chez des personnes qui n'ont aucune pathologie gastrique.



Pourquoi l'acide est indispensable au fer ?

Le fer alimentaire arrive sous deux formes :

Type	Source	Besoin d'acide
Fer hémique	viande, poisson	peu
Fer non hémique	végétaux, céréales, œufs	beaucoup

Le fer non hémique est surtout sous forme Fe^{3+} (ferrique), non absorbable.

Il doit être transformé en Fe^{2+} (ferreux) grâce :

à l'acide chlorhydrique gastrique

Si l'estomac manque d'acide →

le fer reste Fe^{3+} →

il traverse l'intestin... sans être absorbé.



Ce qui se passe en hypothyroïdie

La T3 stimule normalement :

les cellules pariétales gastriques ,la production de HCl ,la vidange gastrique

Quand la T3 est basse (ou la conversion $\text{T4} \rightarrow \text{T3}$ faible) :

Effet	Conséquence
↓ HCl	Fer mal solubilisé
↓ pepsine	Protéines mal digérées
↓ vidange gastrique	Ballonnements, reflux
↓ absorption	Fer, B12, zinc, magnésium ↓

→ Tu peux donc avoir :

une alimentation riche en fer, des compléments et rester carencée car le problème est en amont : l'estomac



Cercle vicieux

Et là on touche le cœur du problème :

Le fer est nécessaire à la thyroïde

Il est cofacteur de :
la thyroperoxydase (TPO)
la conversion T4 → T3

Donc :

Hypothyroïdie → hypochlorhydrie → carence en fer → thyroïde encore plus lente
Un vrai cercle d'auto-entretien.



Lien avec Hashimoto

Dans Hashimoto, c'est encore plus fréquent car :
l'auto-immunité touche aussi souvent l'estomac
gastrite auto-immune fréquente
baisse du facteur intrinsèque
baisse du HCl

→ carence fer + B12 très courante



Pourquoi c'est crucial en TDAH

Dans ton mémoire, ce point est clé :

Le fer est indispensable à :
la tyrosine hydroxylase
la synthèse de dopamine & noradrénaline

Donc hypothyroïdie + fer bas =

→ dopamine basse
→ attention, motivation, énergie en chute



Message clinique fondamental

Quand une personne hypothyroïdienne est carencée en fer, la vraie question n'est pas :

“mange-t-elle assez de fer ?” mais : “est-ce qu'elle a assez d'acide pour l'absorber ?”

